

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN PERSALINAN DENGAN KOMPLIKASI EMBOLI KETUBAN		
	No. Dokumen 571.53/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Prolaps tali pusat adalah keadaan menumbungnya tali pusat disamping atau melewati bagian bawah janin di jalan lahir setelah ketuban pecah.	
Tujuan	1. Bidan RS mampu menganalisa dan memberikan Tindakan pada persalinan dengan prolaps tali pusat 2. Menyiapkan semua perlengkapan alat, obat-obatan dan pasien dengan prolaps tali pusat 3. Bidan mampu memberikan pelayanan asuhan saying ibu dan bayi selama proses persalinan 4. Menurunkan angka kematian bayi (AKB) akibat prolaps tali pusat.	
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.	
Prosedur	1. Siapkan alat 1.1. Siapkan alat-alat: a. Dopler b. Vakum / Forceps c. Partus set d. Handscoon steril 1.2. Dekatkan alat disamping pasien 1.3. Siapkan lingkungan pasien 2. Siapkan pasien 2.1 Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2.2 Perkenalkan diri pada pasien 2.3 Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) 2.4 Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 2.5 Atur posisi pasien dalam posisi <i>dorsal recumbert (menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki)</i> 3. Rincian Prosedur 1. Cuci tangan 6 langkah 2. Pakai APD sesuai standart (Celemek, masker, <i>google</i>, sepatu boot dan sarung tangan)	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN PERSALINAN DENGAN KOMPLIKASI EMBOLI KETUBAN		
	No. Dokumen 571.53/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3

	3. Lakukan anamnesa 4. Lakukan pemeriksaan umum dan khusus (pemeriksaan dalam) pada pasien 5. Segera raba dan temukan tali pusat 6. Jika tali pusat masih berdenyut, berarti janin masih hidup maka segera lakukan : a. Berikan oksigen 4-6 lpm/mnt b. Posisikan ibu pada posisi <i>trendelenbrug</i> (posisi kepala lebih rendah dari bagian kaki) c. Jelaskan pada keluarga dan pasien tentang hasil pemeriksaan dan Tindakan yang akan dilakukan d. Jelaskan segala resiko yang bisa terjadi pada ibu dan bayi saat dilakukan tindakan 7. Jika ibu pada persalinan kala I: a. Pakai sarung tangan steril, lalu masukkan tangan ke dalam vagina dorong keatas bagian terendah janin sehingga tekanan pada tali pusat dapat dikurangi b. Tangan yang lain menahan bagian terendah di supra pubis dan evaluasi keberhasilan reposisi tersebut c. Setelah kolaborasi dengan dokter obgyn, petugas laboratorium dan IKO untuk Tindakan SC CITO ≤ 30 menit d. Lakukan persiapan pasien operasi SC e. Lakukan transfer pasien dengan di damping oleh bidan 8. Jika ibu pada kala II: a. Pada presentasi kepala, kolaborasi dengan dokter obgyn untuk Tindakan vakum b. Jika presentasi bokong lakukan ekstraksi bokong/kaki f. Jika letak lintang segera siapkan SC CITO ≤ 30 menit g. Lakukan persiapan pasien operasi SC h. Lakukan transfer pasien dengan di damping oleh bidan 9. Siapkan alat dan resusitasi bayi baru lahir 10. Jika tali pusat tidak berdenyut berarti janin telah mati dan bukan kasus gawat darurat lagi 11. Melakukan dekontaminasi alat dan tempat partus 12. Cuci tangan 6 langkah 13. Lakukan dokumentasi pada rekam medis (Catat semua advis yang diberikan oleh dokter dan Tindakan yang dilakukan kedalam SOAP) 14. Observasi pasien pasca persalinan selama 2 jam jika
--	--

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN PERSALINAN DENGAN KOMPLIKASI EMBOLI KETUBAN		
	No. Dokumen 571.53/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3

	keadaan umum baik, pasien dipindahkan ke ruang nifas
Unit Terkait	1. IGD 2. MATERNITAS 3. IKO